

המרכז הרפואי קפלן
יש על מי לסמוך

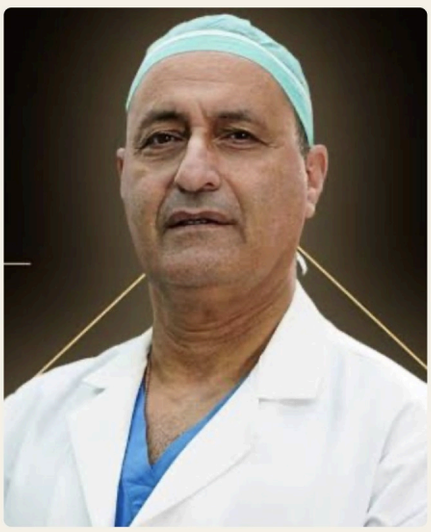
מקבוצת כללית

המערך הכירורגי

ברוכים הבאים לסבב הסטאז׳

כל מה שצריך לדעת על הסבב שלכם במערך הכירורגי: הצוות, הלו״ז, הנהלים ומידע שימושי.

דבר מנהל המערך



ד"ר ברק בר זכאי

מנהל המערך הכירורגי

סטאז'רים יקרים,

ברוכים הבאים למערך הכירורגי במרכז הרפואי קפלן. החודש הקרוב הוא הזדמנות להכיר את העבודה הכירורגית מקרוב: מחלקה פעילה, חדר ניתוח עמוס וצוות שמחויב ללמד.

אתם חלק מלא מהצוות שלנו, העבודה שלכם במחלקה חשובה לנו, בתמורה אנו מתחייבים לליווי, להוראה וליחס אישי לאורך כל הסבב.

גם מי שלא רואה את עתידו בכירורגיה ייצא מכאן עם כלים שילוו אותו בכל תחום.

מאחל לכם חודש מלמד ומוצלח.

קפלן בקצרה

1953	600+	1M~	240
שנת הקמה	מיטות אשפוז	תושבים באזור השירות	דונם שטח הקמפוס

בית חולים אוניברסיטאי המסונף לפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית, המשלב עבודה קלינית עם הוראה ומחקר.

המערך והצוות

מנהל המערך

ד"ר ברק בר זכאי

סגן מנהל המערך

ד"ר רפאל מילר

שני אגפי אשפוז

- **אגף צפון**
- **אגף דרום**

יחידות המערך

01 היחידה לכירורגיה הפטוביליארית

02 היחידה לכירורגיה קולורקטלית

03 היחידה לכירורגיה בריאטרית ולכירורגיה של מערכת העיכול העליונה

04 מכון השד

05 היחידה לכירורגיית דופן הבטן

אנשי הקשר שלכם בסבב

אחראי הסטאז'רים

ד"ר גיא גוזני

כירורג מומחה

אחראי על תוכנית הסבב, הכתובת שלכם לכל נושא מקצועי או אישי.

kaplan.surgery.hub@gmail.com

המתמחה המלווה

ד"ר מחמד עאסלה

מתמחה בכירורגיה כללית

בניית לוח תורניות, חלוקת המשימות היומית והדרכה בעבודה, הכתובת הראשונה שלכם במחלקה.

052-2252319

לוח הזמנים

החודש שלכם

מקליטה מלווה ועד עבודה עצמאית בארבעה שבועות

1

שבוע 1 · קליטה

שיחת פתיחה ותיאום ציפיות, שיבוץ למחלקה ועבודה צמודה עם המתמחים.
קבלת תבניות העבודה והנהלים.

2

שבוע 2 · עצמאות

כתיבת קבלות ושחרורים, שיבוץ לחדר הניתוח, שיפור מיומנויות.

3

שבוע 3 · העמקה

עבודה עצמאית במחלקה, ניתוחים נוספים למי שמגלה עניין והיכרות קרובה עם הצוות.

4

שבוע 4 · סיכום

שיחת סיכום ומשוב אישי, שאלון קצר על הסבב, מילוי טופס הערכת סטאזר, מי שמתעניין בהתמחות מוזמן לשיחה אישית.

המשוב שלכם חשוב לנו

שאלון סוף סבב

כמה דקות בשבוע הרביעי. עוזר לנו לשפר את הסבב הבא

פנייה אנונימית

לכל תלונה או בעיה, בכל שלב בסבב ובלי להזדהות (בפורטל הסטאזר)

השבוע במערך

ישיבות קבועות, לימודים ומרפאות טרום ניתוח

ישיבות | לימודים | טרום ניתוח | הסמינר שלכם

א — ראשון

07:15
ישיבת בוקר

ב — שני

07:00–07:30
לימודי מתמחים

07:30
ישיבת בוקר

ג — שלישי

07:00
ישיבה אקדמית לכל הצוות
ג׳ורנל קלאב, M&M

11:00
טרום ניתוח
אגף צפון

ד — רביעי

07:00–07:30
לימודי מתמחים
שלב א

07:30
ישיבת צוות

10:00
סמינר סטאז׳רים

10:45
ישיבת רנטגן

11:00
טרום ניתוח
אגף דרום

ה — חמישי

07:00
ישיבת צוות
ומעבר על ניתוחי השבוע הבא

חובה להגיע לכל ישיבות הלימודים, הסמינרים וישיבות הבוקר בזמן !
שם מתחיל יום העבודה ושם מתעדכנים במטופלים.

מה מצופה מכם

מה אנחנו מצפים מכם

- נוכחות בישיבת הבוקר לפי הלוח השבועי
- השתתפות פעילה בביקור הבוקר
- היכרות מלאה עם המטופלים באגף שלכם (צפון/דרום)
- אחריות על המשימות שקיבלתם
- דיווח מיידי על כל שינוי במצב מטופל או משהו חריג במחלקה.

מה אתם מקבלים מאיתנו

- ליווי צמוד של צוות המערך לאורך הסבב
- תבניות עבודה ונהלים ברורים
- תוכנית לימוד אקדמית וסמינר שבועי עבור הסטאזרים
- חשיפה לחדר הניתוח
- משוב לאורך כל הסבב, דרך יומן הסבב

סטנדרט העבודה במחלקה

קבלות	קבלה מלאה לפי התבנית ובדיקה גופנית עדכנית במחלקה, בסיום עוברים על הקבלה עם הרופא האחראי.
שחרורים	טיוטת מכתב שחרור והמלצות לפי התבנית, כל מכתב נבדק ומאושר על ידי רופא.
בדיקות דם	לפי הנוהל: הזמנות וערכות מראש, זיהוי וקידוד ליד המיטה, עד שתי דקירות ושליחה מיידית.
אק"ג	ביצוע ופענוח ראשוני, כל חריגה מדווחת מיד לרופא.
חדר ניתוח	עזרה בניתוחים לפי השיבוץ.

יומן הסבב · 30 שניות בסוף כל יום, באפליקציה

כל יום: הייתי? ומה עשיתי (ביקור, דמים, קבלות, חדר ניתוח...). כל חמישי: סיכום שבועי קצר. חמישי אחרון: סיכום הסבב.

למה? כך אנחנו רואים אתכם, מה אתם עושים ומה חסר לכם. כך משפרים את הסבב תוך כדי ולא רק בסופו.

תכנית הטיפול והתשובות למטופלים על המשך הטיפול ניתנות על ידי רופא בלבד, כל משימה שלכם נבדקת ומקבלת משוב, אין שאלה מיותרת.

יום במערך

נהלי העבודה של המערך הכירורגי, בקצרה ובמה שרלוונטי לכם

- **04:00** — **בדיקות דם בוקר**
  לקיחת דמים והכנסת וונפלונים בכל המחלקות, עד 07:00
- **07:00** — **ישיבת בוקר/ישיבת אקדמיה**
  מעבר על הקבלות מהלילה ועל מקרים שדורשים התייחסות מיידית. הישיבה המדויקת בלוח השבועי
- **ביקור בוקר**
  מיד אחרי הישיבה, בראשות רופא בכיר ויחד עם אחות המחלקה
- **15:00** — **סיבוב ערב**
  באחריות הכונן הפעיל והמתמחה הבכיר, יחד עם הצוות הסיעודי, תחילת התורנות בימי חול. בערבי חג ובימי שישי התורנות מתחילה ב-12:00. בסיום הסיבוב המתמחה של האגף מוסר לסטאז׳רים את רשימת הבדיקות לערב ולבוקר
- **17:30** — **בדיקות ערב**
  לפי הרשימה מהמתמחה, עם ערכות שהוכנו מראש (עמוד 13)

סופי שבוע

הביקור מתקיים יחד עם הכונן של אותו יום.

קבלות למחלקה

מטופלים מתקבלים לפי הצד שבקבלה באותו יום. השעה הקובעת היא 07:00.

טראומה

בשעות העבודה מקרי הטראומה מנוהלים על ידי יחידת הטראומה, בתורנות על ידי התורנים וכונני הטראומה

מבוסס על נהלי העבודה והממשקים במערך הכירורגי, באישור מנהל המערך.

קבלה למחלקה

הנחיות לכתיבת קבלה רפואית במחלקה כירורגית

ליד המיטה

- הציגו את עצמכם בפני המטופל
- זיהוי לפי שם מלא ומספר תעודת זהות
- בדיקה גופנית מלאה ועדכנית במחלקה: לב, ריאות, ובדיקת בטן
- יש לשים לב לתוכן/כמות הפרשות בנקזים/זונדה/קטטר שתן
- בדיקה רקטלית רק בנוכחות מתמחה

בכתיבה

- עיקר הקבלה נכתב תחת "מחלה נוכחית"
- רק מה שרלוונטי. לא מעתיקים מידע שאינו תורם
- רשימת תרופות קבועות עדכנית בקמליון, כולל מינונים
- אבחנות בקבלה ובאשפוז בשדות המתאימים
- יש לשים לב להנחיות או הערות מתיק המיון/מרפאות/אשפוזים קודמים וכו׳

מקרים מיוחדים

אלקטיבי לניתוח

משתמשים בקבלה ממרפאת טרום הניתוח, מוסיפים בדיקה גופנית עדכנית, מידע חסר ובירורים שלא הושלמו לפי הנחיית הרופא.

אלקטיבי למכון גסטרו

לפעולות כמו ERCP או EUS נעזרים במכתבי מרפאת הגסטרו, יש לשים לב להנחיות ספציפיות בנוסף לדברים הרגילים (צילום חזה, אק"ג, מעבדה וייעוצים רלוונטיים).

בסיום הקבלה עוברים עליה עם הרופא האחראי, תכנית הטיפול נקבעת על ידי רופא בלבד.

תבנית הקבלה

מבנה מומלץ. אפשר לנסח בשפה שלכם, העיקר שכל הנושאים מכוסים.

01	**פרטים**	גיל. במבוגרים: עצמאי וצלול? ירידה קוגניטיבית ואפוטרופוס
02	**רקע רפואי**	בקצרה ובמה שרלוונטי לאשפוז הנוכחי
03	**נוגדי קרישה**	איזו תרופה ומתי נלקחה המנה האחרונה
04	**רקע ניתוחי**	איזה ניתוח, מתי, באיזו גישה, סיבוכים ומהלך
05	**אנדוסקופיות**	תקין או ממצאים רלוונטיים, ביופסיות ופתולוגיה
06	**מחלה נוכחית**	עיקר הקבלה. תיאור כרונולוגי ברור ומפורט
07	**במיון**	מדדים (חריגים בפירוט), סטורציה באוויר חדר או בחמצן, בדיקה גופנית, דיון ותוכנית טיפול
08	**בדיקות עזר**	מעבדה רלוונטית וכל חריגה משמעותית, הדמיה: ממצאים רלוונטיים וממצאים מקריים משמעותיים
09	**במחלקה**	מדדים ובדיקה גופנית מחדש, נקזים: מיקום, סוג, כמות ואופי. קטטר שתן
10	**תכנית**	לפי הנחיית הרופא בלבד

דלקת כיס מרה פשוטה

מטופל בן 70. כך נראית קבלה שלמה, עם הערות לשוליים.

המרכז הרפואי קפלן
מחלקה כירורגית כללית

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **70**	תאריך קבלה: __/__/____

לדוגמה בלבד

פרטים	בן 70, עצמאי וצלול.
רקע רפואי	מחלת לב איסכמית, צנתור אחרון ב-2020. יתר לחץ דם. סוכרת.
1 נוגדי קרישה/קואגולציה	Aspirin. מנה אחרונה: אתמול בערב.
2 רקע ניתוחי	• כריתת תוספתן בגישה פתוחה, בילדות. • תיקון בקע מפשעתי משמאל בגישה פתוחה עם הנחת רשת, 2013.
אנדוסקופיות	קולונוסקופיה 08/2025: כריתת פוליפ, בפתולוגיה LGD.
3 מחלה נוכחית	פנה עקב כאב בבטן ימנית עליונה מזה שלושה ימים. הכאב הופיע לאחר ארוחה שומנית ומחמיר לאחר אכילה. ללא עליית חום, ללא בחילות או הקאות, וללא תלונות נוספות.
במיון	מדדים חיוניים תקינים. בבדיקה: בטן רכה, רגישות בבטן ימנית עליונה, סימן מרפי חיובי.
מעבדה	לויקוציטוזיס 13,000, נויטרופילים 80%, CRP 5. בילירובין ואנזימי כבד תקינים.
US בטן	כיס מרה עם אבנים ועיבוי דופן. ללא הרחבת דרכי מרה.
4 במחלקה	המטופל מדווח על שיפור בכאבים לאחר משככי כאבים, הוחל טיפול אנטיביוטי. מדדים חיוניים תקינים. בבדיקתו: בטן רכה, אינה תפוחה, רגישות בבטן ימנית עליונה, סימן מרפי חיובי.
5 תכנית	• שתייה צלולה. • טיפול אנטיביוטי. • המשך לפי התכנית בתיק המיון ובהנחיית הרופא.

נכתב ע"י: סטאז'ר/ית [שם] · שעה __:__

הקבלה נסקרה עם: ד"ר [שם הרופא/ה האחראי/ת]

שימו לב

1. נוגדי טסיות וקרישה: תמיד שם התרופה ומועד המנה האחרונה.
2. רקע ניתוחי: איזה ניתוח, מתי, באיזו גישה, וסיבוכים אם היו.
3. המחלה הנוכחית היא לב הקבלה: כרונולוגית, ברורה ומפורטת.
4. בודקים מחדש במחלקה. לא מעתיקים את בדיקת המיון.
5. את התכנית קובעים בדיון עם הרופא, הסטאז'ר מתעד אותה.

דלקת כיס מרה מורכבת

מטופלת בת 90 עם רקע עשיר, נוגדי קרישה ונקז. כאן כל פרט נחשב.

המרכז הרפואי קפלן
מחלקה כירורגית כללית

קבלה רפואית

שם המטופל: **[מטופל לדוגמה]**	ת.ז.: **000000000**	גיל: **90**	תאריך קבלה: __/__/____

לדוגמה בלבד

1 **פרטים**	בת 90, ידועה עם ירידה קוגניטיבית. בנה משמש כאפוטרופוס.
רקע רפואי	סוכרת, מחלת לב איסכמית, פרפור פרוזדורים, מושתלת קוצב, COPD.
2 **נוגדי קרישה**	Eliquis. מנה אחרונה: היום בבוקר.
רקע ניתוחי	• 2021: כריתת מעי גס ימני בלפרוטומיה, עקב חסימת מעי על רקע אדנוקרצינומה. במעקב אונקולוגי בקפלן, מחלה יציבה בביקורת 06/2026. • 2019: כריתת שד חלקית מימין עקב סרטן שד. • 1995: כריתת רחם ושחלות, ללא פרטים נוספים.
אנדוסקופיות	קולונוסקופיה 2024 ללא ממצא חריג.
מחלה נוכחית	פנתה עקב כאב בבטן עליונה מזה ארבעה ימים, עליית חום עד 39 מעלות בבית, ירידה תפקודית וחולשה כללית. הקאות מרובות של תוכן מזון. מעבירה יציאות כרגיל, יציאה אחרונה היום בבוקר.
3 **במיון**	דופק 120, ל״ד 110/50, חום 37.9, סטורציה 85% באוויר חדר, משתפרת תחת חמצן ב-NC. בבדיקתה: בטן רכה, מלאות ורגישות בבטן ימנית עליונה.
מעבדה	לויקוציטוזיס 25,000, CRP 40, INR 1.4. בילירובין 2.5/1.5. AST 150, ALT 150, ALP 200, GGT 250. עמילאז וליפאז תקינים.
CT בטן	אבנים בכיס המרה עם עיבוי דופן וסימני דלקת, ופרפורציה מכוסה לכיוון הכבד.
פעולות	ניקוז כיס מרה במכון לאנגיוגרפיה. התקבלה מרה שחורה, נשלחה דגימה לתרבית.
4 **במחלקה**	דופק 105, ל״ד 130/60, חום 37.4, סטורציה 95% תחת NC. בבדיקתה: בטן רכה, רגישות בבטן ימנית עליונה. נקז כיס מרה: 200 מ״ל תוכן מוגלתי. קטטר שתן: 400 מ״ל שתן מרוכז.
תכנית	• ניטור. • מעבדה חוזרת בערב, כולל תפקודי קרישה. • טיפול אנטיביוטי.

נכתב ע״י: סטאז׳ר/ית [שם] · שעה __:__

הקבלה נסקרה עם: ד״ר [שם הרופא/ה האחראי/ת]

שימו לב

1. ירידה קוגניטיבית ואפוטרופוס: חשובים להסכמה ולחתימה על פעולות.
2. לפעמים צריך לנטרל נוגדי קרישה. מתעדים תרופה ומנה אחרונה במדויק.
3. מדדים חריגים בפירוט. סטורציה באוויר חדר או בחמצן, ובאיזה אמצעי.
4. נקזים: מיקום, סוג, כמות ואופי. קטטר: כמות ואופי השתן.

נוהל לקיחת דמים

זיהוי ובטיחות

קריטי

- חיטוי ידיים לפני הפעולה ואחריה
- זיהוי מטופל לפי שם מלא ומספר תעודת זהות
- קרוס: שני מזהים (שני סטאז׳רים או אחות וסטאז׳ר) נוכחים בלקיחה וחותמים ליד מיטת המטופל בלבד
- טעות בזיהוי לקרוס עלולה להכשיל בסבב ולהוביל לתיק אירוע חריג. כל חשד לטעות מדווח מיד

טכניקה

- עד שתי דקירות. לא הצלחתם? קוראים לעזרה ומדווחים למתמחה
- וונפלון ורוד או ירוק בלבד, לא כחול
- לא מיד שמקבלת עירוי ולא מ-PICC או מליין מרכזי
- לא ברגליים: לא דם ולא וונפלון
- **לפני ניתוח שד: לא בצד הניתוח**
- בסיום מרימים דופנות ושולחים מיד

מה לוקחים

- רוטינה: ספירה, כימיה רחבה ו-CRP
- חום: רוטינה+ תרביות דם
- לפני ניתוח או פעולה חודרנית: ליין ורוד לפחות, ספירה, כימיה וקרישה, מטופל מדמם לפחות ליין ירוק אחד
- קרוס ומנות דם רק לפי בקשת הרופא התורן
- לא הצלחתם בתורנות? מדווחים מיד

לוח זמנים בתורנות

04:00

מתחילים בשני אגפי הכירורגיה ובכירורגית חזה, הרשימה והערכות מוכנות מאחר הצהריים ונמצאות אצל הסטאז׳רים ותורן המחלקה.

07:00

סיום בדיקות הבוקר, אין לצאת מהתורנות לפני 07:00, **במידה ויש בדיקות שלא נלקחו מכל סיבה יש לעדכן את הצוות בבוקר**

17:30

בדיקות ערב עם הערכות שהוכנו מראש, לפי הרשימה מהמתמחה של האגף או לפי בקשת הרופא התורן (עמוד 13)

בדיקות הערב והבוקר: מכינים מראש

ההזמנות וההדפסות נעשות אחר הצהריים. בזמן הלקיחה נשאר רק לזהות, לקדד ולקחת

1 הרשימה מהמתמחה
בסיום ביקור הערב, המתמחה של האגף (צפון או דרום) מוסר את רשימת הבדיקות לערב ולבוקר שלמחרת

2 הזמנה והדפסה
מזינים במערכת את ההזמנות לפי הרשימה, מטופל אחרי מטופל. לכל הזמנה מדפיסים "דו"ח הוראות לקיחה"

3 ערכה לכל מטופל
קונטיינר עם הדף המודפס, המבחנות לפי הסוג שבדף והציוד ללקיחה. המבחנות עדיין בלי מדבקה

4 ליד המיטה
זיהוי בשני מזהים מול הצמיד, קידוד המבחנות במקום ולקיחה

5 הצלבה ומחיקה
מסמנים על הדף של המטופל ומוחקים מהרשימה הכוללת. מה שלא נלקח מכל סיבה מעדכנים את הצוות בבוקר



כללית

המרכז הרפואי קפלן
יש על מי לסמוך

מחלקות

מחלקה כירורגית ב - קפלן

פרטי נבדק	
שם הנבדק	
ת.ז.	
תאריך לידה	
מין הנבדק	
טלפון	
כתובת	

פרטי הזמנה	
מספר הזמנה	
תאריך הזמנה	
זמן הזמנה	
רופא	
הערות הזמנה:	

דו"ח הוראות לקיחה

סוג מבחנה	חומר	זמן דיגומי	בדיקות	הערות
ג'ל שקוף			(CRP,AMYLASE,LDH,GGT,ALT(GPT), AST(GOT),ALK-PHOS,ALB-B,TP-B,P-B, Ca-B,URIC A-B,CREAT-B,UREA-B,GLUCOSE, LIPEMIC,HEMOLYT,ICTERIC,Na,K, Cl,BIL-T	
EDTA סגול			CBC	
פקק תכלת			PTT,PT- PTT	

דוגמה: דו"ח הוראות לקיחה למטופל אחד. פרטי המטופל וההזמנה הוסתרו

בדף רואים איזו מבחנה לכל בדיקה

- ג׳ל שקוף · כימיה
- EDTA סגול · ספירת דם
- פקק תכלת · תפקודי קרישה

שני דברים ביד

הדפים המודפסים (דף לכל מטופל) והרשימה הכוללת מהמתמחה. כך אף בדיקה לא נשכחת

למה ככה

בלילה ובבוקר לא מזינים הזמנות מול המטופל. פחות זמן, פחות טעויות ופחות לחץ

את המבחנות מקדדים רק ליד המטופל

רק אחרי זיהוי בשני מזהים מול הצמיד ומול הרשומה הממוחשבת. אף פעם לא מראש ולא בתחנה

אקדמיה והעשרה

ללמוד מעבר למחלקה

ארבעה סמינרים, ומעטפת לימודית לאורך כל החודש

סמינרי הסבב

1 **המטופל הכירורגי הדחוף** — גישה ראשונית, בטן חריפה, בדיקת בטן וספסיס — 45 דק׳

2 **סדנת תפירה** — מכשירים, להבים, חוטים וחתכים, ותרגול תפרים — 10 דק׳ + תרגול

3 **אפנדיציטיס** — מהתהליך הדלקתי, דרך ההדמיה, ועד הטיפול — 45 דק׳

4 **שוק, נוזלים ואלקטרוליטים** — מאזן נוזלים, בטן פתוחה ו-VAC, האלקטרוליטים החשובים — 45 דק׳

המצגות זמינות בפורטל מהיום הראשון
בלשונית ״ללמוד״ בעמוד האישי שלכם. מומלץ לעבור על כל מצגת לפני המפגש

יום רביעי · 10:00
מפגש הסמינר
בהנחיית רופא בכיר במערך. נושאים קליניים ומעשיים, גם למי שלא יבחר בכירורגיה

לאורך החודש
חדר ניתוח
כל סטאז׳ר משתתף בניתוחים כעוזר. מי שמגלה עניין מקבל שיבוצים נוספים

בביקור הבוקר
הוראה ליד המיטה
פעם בשבוע מוצג ומוסבר מקרה נבחר עבור הסטאז׳רים

מקורות למידה

Sabiston Textbook of Surgery, 22nd ed.	מקור עיקרי
Schwartz's Principles of Surgery	מקור נוסף
Current Surgical Therapy, 14th ed. (2023)	מקור נוסף
UpToDate	לשאלות קליניות ממוקדות



העתיד שלכם

חושבים על כירורגיה?

המערך פועל בנפח ניתוחים גבוה מאוד, המתמחים נחשפים למגוון רחב של מקרים ומורכבויות עם דגש על עבודה מעשית ובניית עצמאות אמיתית בחדר הניתוח.

רמה קלינית מובילה
יחידות מקצועיות מתקדמות ואחריות אמיתית על מטופלים

ניתוחים מורכבים
הניתוחים המתקדמים בתחום, בטכניקות ובציוד המובילים

ליווי אקדמי צמוד
סמינרים וג׳ורנל קלאב, אחוזי הצלחה גבוהים בבחינות

מבט אל העתיד
עידוד למחקר, אקדמיה ופרויקטים של יזמות וחדשנות

מסלול המתמחה

1 **תצפית ולמידה**
היכרות עם הטכניקה והחשיבה הניתוחית

2 **סיוע פעיל**
לצד הצוות הבכיר

3 **ביצוע בליווי**
שלבים מרכזיים תחת הנחיה

4 **עצמאות**
אחריות מלאה וביטחון עצמי

סטאז׳ ← תורני חוץ ← התמחות

לשיחה אישית ולשליחת קו״ח · ד״ר גיא גוזני
kaplan.surgery.hub@gmail.com